

1 実践チェックリスト(保険薬局/病院)

保険薬局薬剤師

- ☐ 具体的な動作でしびれを聞き取り、経時的に記録
- ☐ 転倒・やけど・靴ずれの予防を生活に即して指導
- ☐ デュロキセチン等の効果と眠気・ふらつきの確認
- ☐ 他院処方(抗真菌薬・抗うつ薬等)の相互作用確認
- ☐ 生活への支障をトレーシングレポートで病院へ

病院薬剤師

- ☐ 累積投与量の管理と減量・休薬基準の確認
- ☐ 投与前のGrade評価と処方医への提案
- ☐ オキサリプラチンの急性症状・過敏症への院内対応
- ☐ 計画的な休薬や皮下投与など投与法の提案
- ☐ お薬手帳へのレジメン・Grade・累積量の記載

病院と共有する情報

レジメン・累積投与量

しびれのGrade・経過

対症療法の効果・副作用

転倒・やけど等の生活上の支障

2 予防と対症療法 — エビデンスの整理

対策	対象・方法	位置づけ	薬剤師の確認ポイント
減量・休薬・投与法の工夫	オキサリプラチンの計画的な休薬、ボルテゾミブの皮下投与など	最も確実な対策	症状の推移を処方医へ伝える
デュロキセチン	痛みを伴うCIPN	有効性が示され、ガイドラインで推奨	国内ではCIPNは適応外。悪心・眠気、併用薬によるセロトニン症候群
プレガバリン・ミロガバリン	神経障害性疼痛	CIPNへの有効性は限定的	眠気・ふらつきによる転倒、腎機能に応じた用量
冷却・圧迫療法	タキサン系の投与中に手足を冷却・圧迫	予防効果の報告あり(施設の方針による)	冷えの不快感・凍傷
牛車腎気丸・ビタミンB12	慣習的に使われることがある	予防・治療効果は確立していない	効果を確認し、継続の要否を処方医と相談

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サプリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
注意	ピンクリスチン・ボルテゾミブ等 CYP3A4阻害	処方薬 アゾール系抗真菌薬・クラリスロマイシン	血中濃度↑ → 神経障害↑	他院の抗真菌薬・抗菌薬を確認
注意	デュロキセチン セロトニン作用の重複	処方薬 SSRI・トラマドール・トリプタン系	セロトニン症候群	他院の抗うつ薬・鎮痛薬を確認
注意	プレガバリン・ミロガバリン 中枢抑制の重複	処方薬 生活習慣 オピオイド・睡眠薬・飲酒	眠気・ふらつき → 転倒	腎機能に応じた用量と転倒リスクを確認
確認	オキサリプラチン 寒冷刺激で誘発	生活習慣 冷たい飲食物・冷氣	手足・のどのしびれ	投与後数日は常温の飲み物、手袋・マフラーを
確認	神経障害を・起こす薬剤全般 既存の神経障害	既往・疾患 糖尿病・アルコール多飲	CIPNが重症化しやすい	既往を把握し処方医と共有

4 服薬指導の声かけ例と確認のタイミング

治療開始前

「しびれは薬の量が増えるにつれて出やすくなります。ボタンかけや字を書く時の変化を教えてください」

確認:お薬手帳でレジメン、糖尿病・アルコール多飲など神経障害の既往
△ しびれは我慢せず伝えるよう説明

投与後～数日

「冷たい物に触れたり飲んだりすると、手足やのどがしびれることがあります」(オキサリプラチン)

確認:急性症状の有無、冷たい飲食や外気への対策
△ 息苦しさで発疹・血圧低下を伴えば過敏症を疑い連絡

数コース後

「前回と比べて、しびれで困る動作は増えましたか。箸やボタン、歩く時はいかがですか」

確認:同じ質問で経時比較、転倒・やけどの有無、鎮痛薬の効果と副作用
△ 生活への支障(Grade2以上)は処方医へ情報提供

治療終了後

「治療が終わってしばらくは、しびれが強くなることもあります。続く時は教えてください」

確認:中止後の悪化、運転・仕事への影響、対症療法の継続の要否
△ 長く残る症状は処方医と継続して共有